

기억력 저하로 내원한 73세 여성

증례

73세 여성이 내원 1년 전부터 기억력 저하가 뚜렷하다고 호소하면서 치매 진단을 받기 위해 외래를 방문하였다. 고혈압으로 약물을 복용 중이었으며, 모친이 치매를 앓다가 사망한 가족력이 있었다. 환자는 남편과 거주하면서 살림하거나 외출하는 데에는 도움이 필요치 않았으나, 마트에 물건을 사러갔다가 한두 가지를 잊어버리고 온다거나 물건을 어디에 뒀는지 기억이 나지 않는 증상이 반복된다고 하였다. 기억력 외에 언어 기능이나 계산력, 방향 감각, 판단력 저하 등 다른 증상은 없었다. 환자의 남편이나 자녀들은 예전보다 자주 건망증이 있어 보인다고 하였다.

외래 초진 당시 신경학적 이상 소견이 없었

으며, mini-mental state examination(MMSE) 검사에서 26(표준 점수 55.4 percentile), 임상 치매 척도(clinical dementia rating, CDR)는 0점에 해당하였다. 뇌영상 MRI 검사에서는 뇌실 주변에 경미한 백질변성 외에 다른 이상 소견은 없었으며, 해마위 축은 없었다. 신경 인지 기능 검사(Seoul neuropsychological screening battery, SNSB)에서 인지 기능의 전영역에서 정상 수행을 보여 주관적 인지 저하를 진단하였다(그림 1). 치매 가족력이 있으며, 아포지방단백 4번 유전자형(apolipoprotein epsilon 4, APOE4) 보유자였고, 주관적으로 호소하는 증상이 심하여 아밀로이드 펩트(florbetaben PET)(그림 2)를 촬영하였으나 음성 소견을 보여 알츠하이머병을 배

제할 수 있었다. 이후 4년간 추적 관찰하였으나 임상적 진행을 보이지 않았고, 4년 뒤 신경 인지 기능 검사에서도 정상 수행을 보였다(그림 3).

고찰

주관적 인지 저하(subjective cognitive decline, SCD)는 지속적인 인지 저하를 호소하는 대상자가 병원을 방문하여 치매 검사를 받았으나, 신경 인지 기능 검사에서 정상 소견을 보일 때 진단한다. 인지 기능 검사에서는 객관적인 인지장애를 보이지 않으나 미세한 인지 저하(subtle cognitive decline)가 생겼기 때문에 이를 보완하기 위해 끊임없이 노력하게 되고 스스로가 이러한 변화를 가장 먼저 인지하게 되는

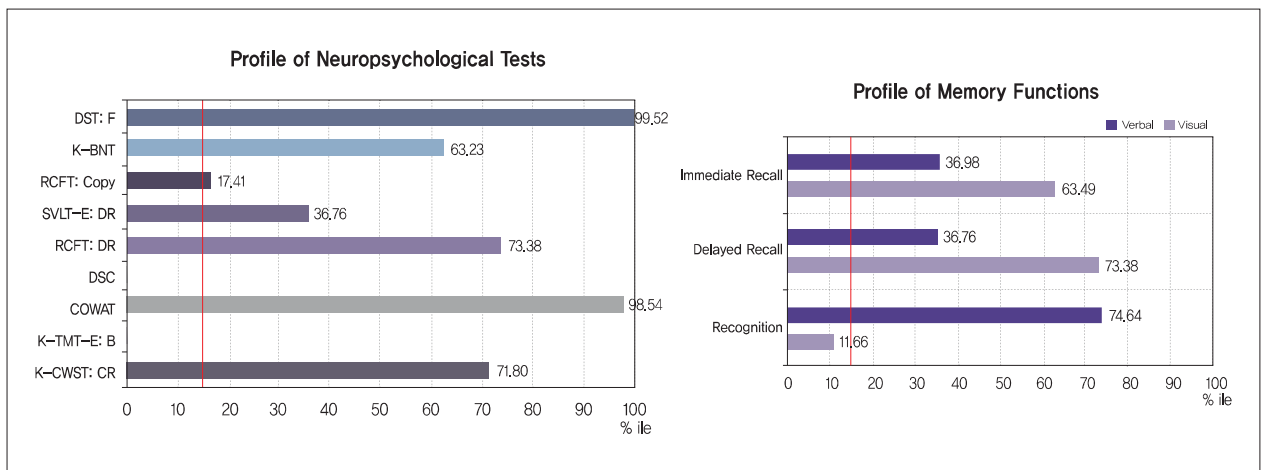


그림 1. 환자의 기초 신경 인지 기능 검사

시기이다. 노년기에 흔히 나타나지만 약 20%에서 전임상 알츠하이머병에 해당하므로 알츠하이머병의 첫 증상이라는 점에서

중요하고, 치매 위험도가 약 2배 증가한다고 알려져 있어 위험군에 해당한다.

그러나 대부분의 환자는 알츠하이머병

이 아니며, 전임상 알츠하이머병이라고 하더라도 연간 진행률(경도 인지장애 또는 치매)이 약 5~10%에 지나지 않는다는 점을 유념할 필요가 있다. 또한 아직까지는 이 시기에 권장되는 알츠하이머병 관련 약물 치료가 없다. 따라서, 고위험군을 적절히 선별해내고 고위험군에서 1~2년마다 임상적 진행 여부를 판단하는 진료를 권유하고 생활습관 관리 및 혈관성 위험인자 관리 등 비약물적 예방에 집중할 수 있다.

본 증례의 경우 알츠하이머병이 배제되었고, 뇌MRI 영상에서 혈관 병변이나 뚜렷한 뇌위축 소견이 없으므로 장기간 추적 관찰에서도 정상 인지 기능을 유지하는 좋은 경과를 보였다.

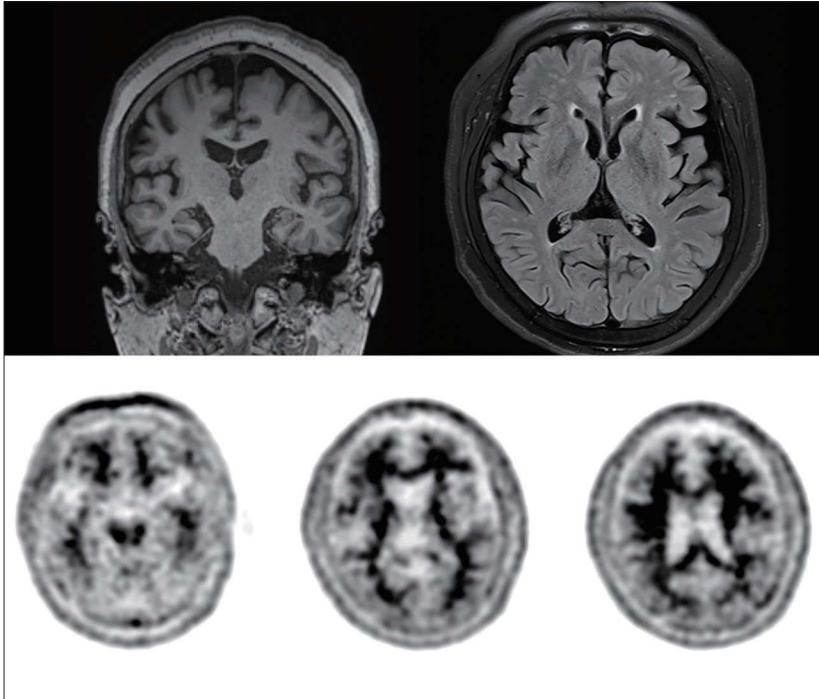


그림 2. 환자의 MRI(위), florbetaben PET(아래)

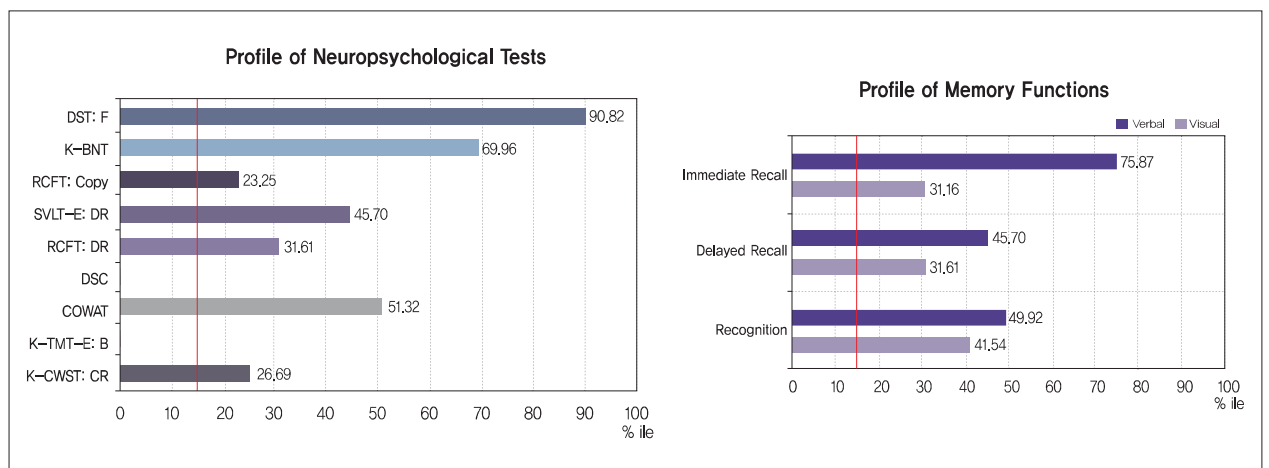


그림 3. 4년 뒤 신경 인지 기능 검사